

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Акушерство на линии

Кровотечения, разрывы, гипертензия, ТЭЛА и решение «рожать
здесь или везти»

По практическому занятию на Центральной подстанции СМП Москвы (август 2026) и
Алгоритмам СМП 2025, раздел 9.

Клинические эпизоды — из разбора на занятии, обезличены.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 23 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Два эпизода с занятия

Десять недель и «простуда». Беременность 10 недель. Кровохарканье, слабость, были обмороки, боль в ягодичной области. Гемодинамика стабильна. SpO₂ 95 %, частота дыхания 22 в минуту, синусовая тахикардия 110, электрокардиограмма без ишемических изменений. В медцентре назначен мукалтин. В инфекционном стационаре — судороги и клиническая смерть. Диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Двадцать семь недель и «встать на учёт». Женщина впервые пришла становиться на учёт в 27 недель. В разошедшийся рубец на матке провалилась пяточка плода. Ногу сохранить не удалось: шёл некроз. Клиники свершившегося разрыва — кинжальной боли и шока — до этого не было.

Разбор обоих эпизодов — в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Чем прогрессирующая внематочная беременность отличается от нарушенной по типу трубного аборта и по типу разрыва трубы — и почему задержки менструации может не быть?
2. Почему головная боль, нарушение зрения или боль в эпигастрии при артериальном давлении ниже 160/110 мм рт. ст. меняют объём помощи при преэклампсии?
3. Как по боли и наружному кровотечению различить краевую, центральную и смешанную отслойку плаценты?
4. Чем угрожающий и свершившийся разрыв матки отличаются от «тихого» расхождения рубца и что даёт симптом Вастена?
5. Что проверяет признак Пискачека и какое решение он принимает на вызове?
6. Почему стабильная гемодинамика и «нормальная» электрокардиограмма не снимают тромбоэмболию лёгочной артерии у беременной с кровохарканьем и обмороками?

Аномальные маточные кровотечения

По Алгоритмам СМП 2025 (N92, N93, N95) аномальное маточное кровотечение — показание к эвакуации: катетеризация вены, транексамовая кислота 1000 мг внутривенно, транспортировка на носилках. При шоке — протокол геморрагического шока.

На занятии отдельно разобрана рабочая развилка линии. Скудные мажущие выделения без признаков кровопотери не закрываются как «неотложное кровотечение»: это может быть патология эндометрия, перименопаузальное кровотечение и другие состояния, связанные с циклом. В такой ситуации согласование идёт через акушерский пункт — направление и обратный звонок акушеров, а не самостоятельное «отпускание» без маршрута. Код, которым на занятии называли эту группу, — 2885, N90.8; в алгоритме госпитализируемые кровотечения стоят под N92-N93 и N95.

Апоплексия яичника

Три клинических варианта: болевой, анемический и смешанный.

Боль наступает внезапно, чаще односторонняя, с иррадиацией в крестец, копчик, нижние конечности. Эпизод возможен на фоне полного благополучия, в том числе среди ночи. Срок цикла не обязан быть серединой: апоплексия случается в любую фазу.

Дифференциал — овуляторный синдром (mittelschmerz): там боль короче, гемодинамики нет, живот не даёт картины внутрибрюшного кровотечения.

По алгоритму (N83: апоплексия, разрыв или перекрут кисты) — венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг или этамзилат 500 мг, эвакуация на носилках.

Внематочная беременность

Две большие группы: **прогрессирующая** и **нарушенная**.

Прогрессирующая. Периодически повторяющиеся выделения и боли. Заподозрить можно по анамнезу и первому дню последней менструации, но задержки менструации нет почти у половины пациенток: кровянистые выделения принимаются за «очередные месячные». Лечение на догоспитальном этапе алгоритм не требует; эвакуация обязательна.

Нарушенная по типу трубного аборта. Стертая картина: выделения, болевой синдром, который сам по себе затихает. Женщина может ходить так до месяца. Это не «прошло», а медленное кровотечение в трубу и брюшную полость.

Нарушенная по типу разрыва трубы. Обморочное состояние, холодный липкий пот, резкая кинжальная боль. При осмотре патология в нижних отделах живота. По алгоритму: пульсоксиметрия, венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, эвакуация на носилках; при шоке — протокол геморрагического шока.

Живот осматривается целиком, не только «над лоном». Внематочная, тяжёлая преэклампсия и разрыв матки по дну на занятии разбирались как состояния, которые дают картину острого живота. Если клиника удерживает оба диагноза — в карте фиксируется двойной, а не «более удобный» один. Звонок на акушерский пункт при любой из этих картин у беременной или у женщины с возможным сроком.

Тромбоэмболия лёгочной артерии при беременности

Беременность — тромбогенное состояние с первого триместра, не «с третьего». Кровохарканье, необъяснимая одышка, тахикардия, обмороки, боль в ягодичной или тазовой области (эмбол из тазовых и проксимальных вен) складываются в сосудистый, а не «простудный» диагноз. Мукалтин на кровохарканье не отвечает.

Электрокардиограмма при субмассивной тромбоэмболии часто не показывает перегрузку правых отделов. Стабильное артериальное давление означает лишь то, что компенсация ещё держит системное давление; оно не измеряет тромботическую нагрузку. Кардиопульту передаётся клиника целиком, включая обмороки и кровохарканье, а не только «плёнка без изменений».

Судороги и остановка в стационаре в разобранном эпизоде — исход эмболии, а не «нейроинфекции», под которую пациентку успели маршрутизировать.

Гипертензивные расстройства

Три сущности, которые не заменяют друг друга.

Состояние	Срок появления	Суть
Хроническая артериальная гипертензия	До 20 недель либо существовала ранее	Гипертензия, которую беременность застала, а не создала
Гестационная артериальная гипертензия	После 20 недель	Повышение давления без критериев преэклампсии
Преэклампсия	Обычно после 20 недель, возможна послеродовая	Гипертензия плюс органное поражение; на линии — по давлению и симптомам

Объём помощи задаёт не одно число на манжете.

Картина	По Алгоритмам СМП 2025
Умеренная преэклампсия, АД 140–160 / 90–110, без головной боли, зрительных нарушений, тошноты, рвоты, боли в эпигастрии или правом подреберье	Нифедипин 10 мг внутрь . Сублингвально противопоказан
Та же цифра АД, но есть любой из перечисленных симптомов	Нифедипин 10 мг внутрь и магния сульфат: 4000 мг (16 мл) внутривенно за 10–15 мин, затем 1000 мг/ч
Тяжёлая: АД $\geq$ 160/110 независимо от симптомов	Тот же объём, что при умеренной с симптомами
Целевое давление	САД 130–150, ДАД 80–95 мм рт. ст. Ниже 100/80 не снижать: риск нарушения плацентарной перфузии

На занятии формулировка совпала с алгоритмом: «только нифедипин» — это умеренная преэклампсия без субъективной симптоматики. Головная боль, нарушение зрения, головокружение, боль в эпигастрии при давлении «ещё не 160» уже переводят случай в тяжёлый по объёму помощи — нифедипин плюс магния как профилактика судорог.

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

Три геометрических варианта, от которых зависит, будет ли кровь снаружи.

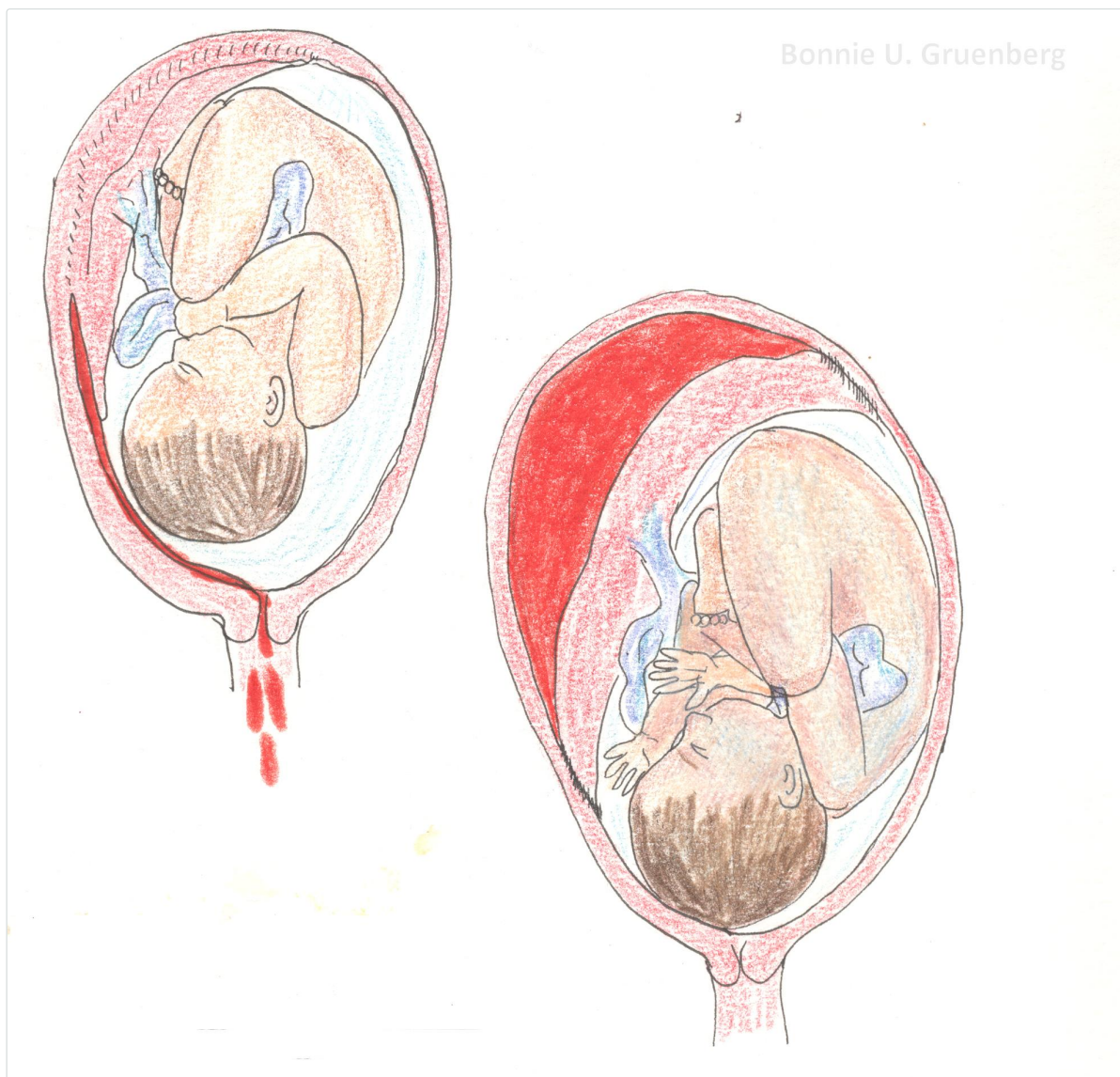


Рис. 1. Сверху — краевая (revealed) отслойка: кровь находит путь наружу. Снизу — центральная (concealed): ретроплацентарная гематома без выделений. Смешанная форма сочетает оба пути и на рисунке не показана. Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Форма	Кровь снаружи	Боль	Что происходит
Краевая	Есть наружное кровотечение	Болевого синдрома может не быть	Отслойка с края, кровь стекает по оболочкам
Центральная	Выделений нет	Выраженная боль	Формируется ретроплацентарная гематома; матка напряжена, «деревянная»
Смешанная	Есть и гематома, и наружное кровотечение	Боль плюс выделения	Сочетание обоих путей

Объём наружной крови не равен объёму кровопотери. При центральной отслойке женщина бледнеет и входит в шок при «сухих» простынях. Влагалищное исследование противопоказано. По алгоритму (О45): венозный доступ, натрия хлорид 250-500 мл, транексамовая кислота 1000 мг, эвакуация на носилках.

Разрыв матки

На занятии разделяли «тихий» и свершившийся разрыв.

Гистопатический (гистохимический) разрыв, расхождение рубца. Может идти бессимптомно. Возможны покалывания, симптом ниши в области рубца. Область рубца осматривается прицельно, сердцебиение плода выслушивается. Эпизод с пяточкой в разошедшемся рубце в 27 недель — край этого спектра: плод уже в дефекте, а картины «кинжала и шока» ещё нет.

Свершившийся разрыв. Дикая кинжальная боль, шок. Предлежащая часть может уйти вверх. Положительный симптом Вастена (головка не прижимается ко входу в таз / «нависает» над лоном при несоответствии размеров) позволяет заподозрить препятствие и угрозу разрыва ещё до катастрофы.

По алгоритму (O71: угрожающий, начавшийся, свершившийся): пульсоксиметрия, венозный доступ, натрия хлорид 250–500 мл; при начавшемся и свершившемся — транексамовая кислота 1000 мг; эвакуация на носилках.

Роды: осмотр и решение «здесь или в стационар»

Приёмы Леопольда

Четыре наружных приёма отвечают на четыре вопроса: что в дне, где спинка, что предлежит, насколько предлежащая часть вошла во вход в таз. Третий приём — захват предлежащей части над лоном — может быть болезненным; выполняется осторожно.

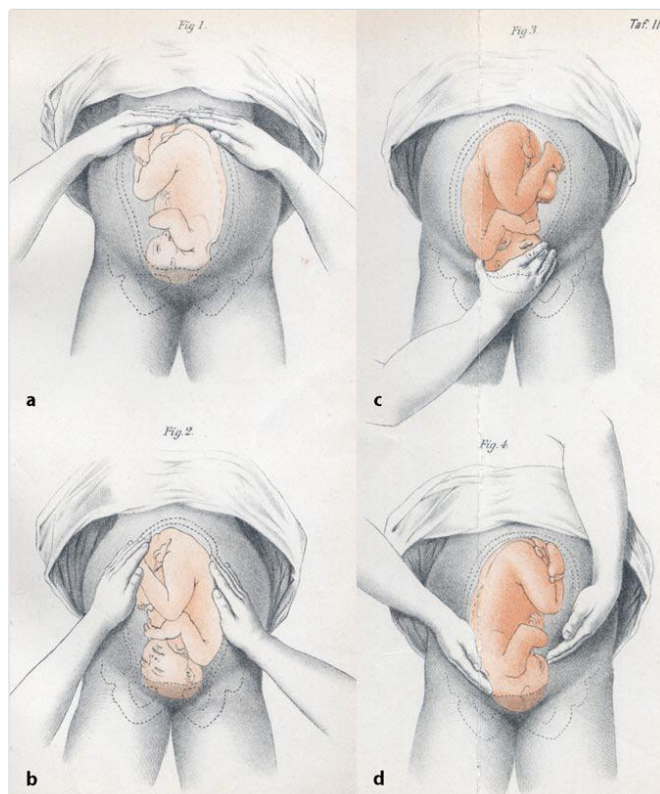


Рис. 2. Приёмы Леопольда. Fig. 1 — дно матки. Fig. 2 — стороны матки (спинка и мелкие части). Fig. 3 — предлежащая часть над входом в таз, одной рукой (приём может быть болезненным). Fig. 4 — отношение предлежащей части ко входу в таз, руки направлены к тазу. Christian Gerhard Leopold, 1894; общественное достояние.

Признак Пискачека

Решение «рожать на месте или везти» на занятии завязано на этот признак, а не на ощущение «уже не успеем».

Техника: два пальца и стерильная салфетка; через большую половую губу достигают головки, **не входя во влагалище**. Если головка пальпируется — она на тазовом дне, потужной период состоялся, эвакуация в этом положении невыполнима. Если головки нет — машина едет.

Открытой лицензионной схемы именно этого приёма нет. Классический «признак Пискачека» в учебниках — другое: асимметрия матки в ранние сроки беременности (Piskaček, 1899). Название на занятии относится к приёму определения стояния головки, а не к этому раннему знаку.

На станции домашние роды закрываются кодом, который на занятии называли 1641 (в алгоритме — O80, «домашние роды» / «роды вне родильного дома»). Если роды принимаются на месте, объём — по разделу «Домашние роды»: аускультация сердцебиения плода, венозный доступ, акушерское пособие, лоток под половые пути, окситоцин 10 МЕ внутримышечно в бедро после рождения ребёнка, осмотр последа и доставка его в роддом, контроль каждые 15 минут в течение двух часов.

Пособие в родах: что называть по имени

На занятии перечислены приёмы, которые алгоритм требует знать по названию. Здесь — только роль каждого, без «выучить руками по абзацу».

Приём	Когда
Пособие при переднем виде затылочного предлежания	Типичные головные роды: защита промежности, сдерживание разгибания головки, рождение переднего, затем заднего плечика
Цовьянов I	Чисто ягодичное предлежание: ножки удерживаются прижатыми, пока не родится туловище до нижнего угла лопаток
Цовьянов II	Ножное предлежание: ножки «удерживаются» до рождения ягодич, чтобы не родиться ножками слишком рано
Классическое ручное пособие / приём Ловсета	После рождения до нижнего угла лопаток, если ручки запрокинулись
Морисо-Левре-Ляшапель (в алгоритме — Морисо-Смелли-Вайт)	Последующая головка не рождается самостоятельно: сгибание головки, ребёнка не тянуть на себя

По алгоритму при тазовом предлежании пособие не оказывается до самостоятельного рождения ребёнка до уровня пупка. Тянуть ребёнка на себя запрещено.

Возвращение к эпизодам

Десять недель. Кровохарканье плюс обмороки плюс тахикардия 110 плюс частота дыхания 22 плюс SpO₂ 95 % у беременной — это лёгочная эмболия в дифференциале, пока не доказано иное. «Нормальная» плёнка и стабильное давление эмболию не исключают. Мукалтин закрыл дыхательную жалобу и убрал пациентку с сосудистого

маршрута. Судороги и остановка в инфекционном стационаре — цена этого маршрута, а не отдельная болезнь.

Двадцать семь недель. Отсутствие кинжальной боли не исключает расхождения рубца. Покалывания, ниша, «не так шевелится», поздняя постановка на учёт при рубце на матке — повод посмотреть область рубца и слушать сердцебиение, а не ждать шока. Когда пяточка уже в дефекте, катастрофа свершилась анатомически, даже если гемодинамика ещё держится.

Ответы на вопросы для размышления

1. Прогрессирующая — повторяющиеся боли и выделения при целой трубе; задержки менструации может не быть, потому что кровянистые выделения принимаются за цикл. Трубный аборт — стертая, волнообразная боль, женщина ходит днями и неделями. Разрыв трубы — кинжальная боль, холодный пот, обморок, картина внутрибрюшного кровотечения. Объём помощи на линии есть только у нарушенной: доступ, кристаллоид, транексам, носилки.
2. Алгоритм считает умеренную преэклампсию «без субъективной симптоматики» и «с симптоматикой» разными строками. Симптомы (голова, зрение, диспепсия, эпигастрий) при АД 140–160 / 90–110 добавляют магния сульфат 4000 мг с поддержкой 1000 мг/ч к нифедипину 10 мг внутрь — тот же объём, что при АД $\geq 160/110$. Цифра 160 не является единственным порогом тяжести.
3. Краевая — наружное кровотечение, боли может не быть. Центральная — ретроплацентарная гематома, наружных выделений нет, боль выражена, матка напряжена. Смешанная — и гематома, и кровь снаружи. Объём видимой крови не равен кровопотере.
4. «Тихий» разрыв идёт по рубцу: покалывания, ниша, иногда пролабирование части плода без шока. Свершившийся — кинжальная боль и шок, подлежащая часть уходит. Симптом Вастена положительный при несоответствии головки и входа в таз — маркер угрозы, а не доказанный разрыв.
5. Признак Пискачека отвечает на вопрос, достигла ли головка тазового дна. Два пальца со стерильной салфеткой через большую половую губу, без влагалищного исследования. Головка пальпируется — роды принимаются на месте. Не пальпируется — эвакуация.
6. Субмассивная эмболия часто оставляет системное давление и электрокардиограмму без «классики». Кровохарканье, обмороки, тахипноэ, тахикардия и беременность весят больше, чем спокойная плёнка. Кардиопульту передаётся эта клиника, а не заключение «ЭКГ норма».

Источники

- Практическое занятие по акушерству, Центральная подстанция скорой медицинской помощи Москвы, август 2026 (рабочие формулировки линии: акушерский пункт, признак Пискачека, коды повода).
- Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи (Департамент здравоохранения города Москвы, 2025), раздел 9 «Акушерство и гинекология»: N83, N92–N95, O00, O10–O16, O14, O15, O44, O45, O71, O80.
- Клинические рекомендации: внематочная беременность; преэклампсия, эклампсия, гипертензивные расстройства во время беременности; преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты; роды вне стационара.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
otsloyka_marginal_concealed.jpg	Краевая (revealed) и центральная (concealed) отслойка	Bonnie Urquhart Gruenberg, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
leopold_1894.jpg	Четыре приёма Леопольда	Christian Gerhard Leopold, 1894; Leopold und Spörlin, <i>Arch Gynäkol</i> 45: 337–368; Wikimedia Commons, общественное достояние

Сгенерированные схемы из версии 1.0 сняты: на них были латинская транслитерация вместо кириллицы и неверное положение рук при третьем приёме Леопольда.

Выходные данные

Материал: «Акушерство на линии». Версия 1.1 от 23 августа 2026. Иллюстрации заменены на лицензионные первоисточники.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Коды повода (2885, 1641) приведены как рабочие формулировки занятия; при расхождении с действующим справочником станции приоритет у справочника и у Алгоритмов СМП.

О клинических эпизодах. Эпизоды рассказаны на занятии и обезличены: нет имён, дат, адресов, номеров карт и названий стационаров. Совпадения с чужой практикой возможны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией.